FC	80	[SR]	. Rythme sinusal
FR	750	$[QMBW]	. Décalage de la ligne de base sur dérivation(s) V2
PR	144		
QRSd	89		
QT	361		
QTcB:	417		
QTcF:	397		
--AXE--			
P	49		
QRS	46		
T	53		

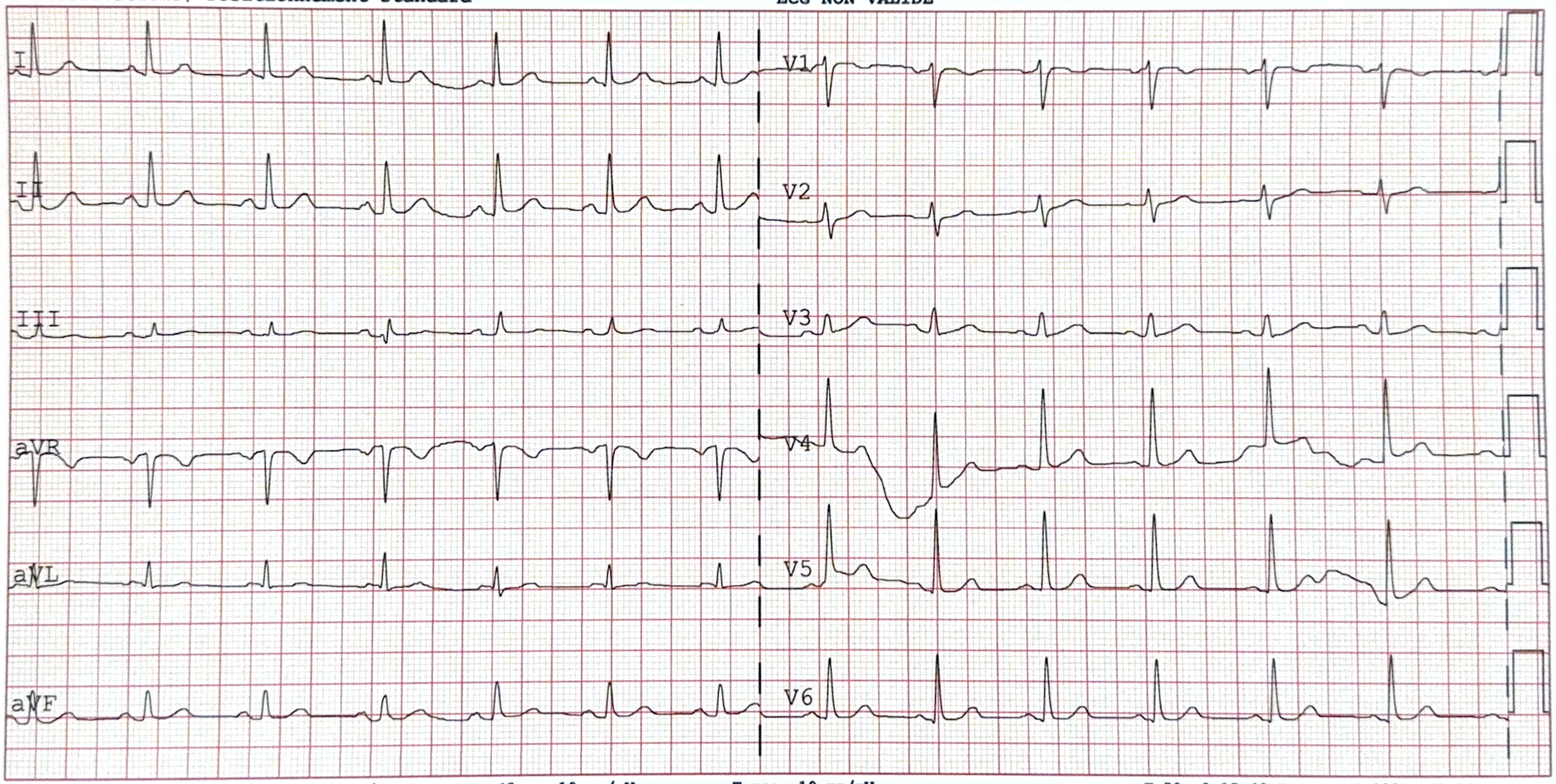
Opér: HM-POLI

Affecté à: URGENCES HM (URG_HM_>
Unité: Unknown
NO ADMISSION: 214941790

-ECG NORMAL -

12 dérivations; Positionnement standard

ECG NON VALIDE



Appar.: 20020606 Vit.: 25 mm/sec Mbre: 10 mm/mV Torse: 10 mm/mV F 50~ 0.15-40 Hz PH100B CL P?

CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG

HÔPITAL MUNICIPAL ▪ CLINIQUE PÉDIATRIQUE ▪ MATERNITÉ ▪ CLINIQUE D'EICH

LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE 4 rue Barblé L-1210 Luxembourg

F. BENKHADRA Méd.Biol. R. LA SCHIAZZA Pharm. Biol. F. DEBAUGNIES Pharm. Biol.
V. SCHLESSER Pharm. Biol. JH. FRANCOIS Pharm. Biol.
C. TSOBO Méd. Biol. M. KOHNEN Méd. Biol.

: 4411-4577
: 4411-2180
: Sec.Labo@chl.lu

Patient:
[redacted]

Dr [redacted]
CHL

L-1210 LUXEMBOURG

Date de naissance : [redacted]
Envoyé à : [redacted]

Références CHL/Ext : [redacted]
Service : [redacted]
Matricule : [redacted]
Type d'édition : **Complet**

Prescription du : 30/12/2025, Reçu le 30/12/2025
Dossier du : 02/01/2026 à 09:14
Date d'édition : 07/01/2026 à 14:35

	Résultats	Unités	Références	Antériori@	Dates

Renseignements cliniques fournis

BIOCHIMIE

Prélevé le: 02/01/2026 à 09:14:00, Sérum 10 ml (tube bouchon rouge)

Aspect échantillon sérum

hémolyse à 36 mg/dl d'hémoglobine
limpide
non ictérique

Analyses biochimiques : SANG

° Urée	27	mg/dl	17-48	25	30/12/25
° Créatinine (technique enzymatique)	0.84	mg/dl	0.51-0.95	0.84	30/12/25
DFG (MDRD) /1.73 m2	>60.0	ml/mn	>60.0	>60.0	30/12/25
DFG (CKD-EPI) /1.73 m2	75.6	ml/mn		75.6	30/12/25
° Acide urique	5.0	mg/dl	2.4-5.7		
° Sodium	138	mmol/l	136-145	142	30/12/25
° Potassium	4.6	mmol/l	3.5-5.1	3.8	30/12/25
° Chlore	101	mmol/l	98-107	103	30/12/25
° Cholestérol total	↑ **243**	mg/dl	130-200		
° HDL-cholestérol	63	mg/dl	>40		
° LDL-cholestérol	158	mg/dl			
non-HDL-cholestérol	180	mg/dl			
° Triglycérides	119	mg/dl	<150		

Cibles (mg/dl) en fonction du risque cardiovasculaire (RCV) selon recommandations ESC/EAS 2019 mises à jour en 2025 :

	LDL-cholestérol	non-HDL-cholestérol	Classe de recommandation
RCV extrême	<40 + *		IIb
RCV très élevé	<55 + *	<85	I **
RCV élevé	<70 + *	<100	I
RCV modére	<100	<130	IIa
RCV bas	<116		IIb

* réduction de >=50% par rapport au taux pré-thérapeutique
** IIa si prévention primaire et hypercholestérolémie familiale
[liens: doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455 ; doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf190]

Remarque pour le patient sous traitement hypolipémiant: une valeur de cholestérol total ou LDL abaissée n'est pas une raison pour arrêter votre traitement de votre propre initiative.

° Bilirubine totale	0.81	mg/dl	<1.20		
° GOT (37°C)	24 (1)	U/l	<35	22	07/11/24
° GPT (37°C)	20	U/l	<35	14	07/11/24
° Gamma GT (37°C)	10	U/l	<40	18	07/11/24

Commentaire Dossier:

GED_C-CHL / GED_C-CHL

CHL

[redacted]

né(e) le: [redacted]

Réf. labo : [redacted]
Service : [redacted]
Prél.du : 02/01/2026 à 09:14
Edition du : 07/01/2026 à 14:35

Type d'édition : Complet

	Résultats	Unités	Références	Antériori@	Dates
Biochimie Hématologique					
° Acide folique (à jeun)	9.3 (1)	ng/ml	5.6-45.8		
Hormonologie : SANG					
25-OH Vitamine D totale	90	nmol/l			
< 25 nmol/l		Déficience en vitamine D			
< 50 nmol/l		Insuffisance en vitamine D			
> 75 nmol/l		Taux optimal en vitamine D			
> 250 nmol/l		Risque de toxicité			

BIOCHIMIE

Prélevé le: 02/01/2026 à 09:14:00, Sang total sur EDTA (tube bouchon mauve)

Analyses biochimiques : SANG			
HbA1c (DCCT)	5.1	%	voir
(électrophorèse capillaire Sebia)			seuils ADA
HbA1c (IFCC)	33	mmol/mol	
eAG (glucose estimé moyen)	100	mg/dl	

Seuis décisionnels HbA1c (ADA)

5,7-6,4% (39-47 mmol/mol) : prédiabète ; risque très élevé >6,0% (42 mmol/mol)

>= 6,5% (48 mmol/mol) : diabète

Principaux facteurs pouvant influençer le résultat de l'HbA1c :
* Une régénération érythrocytaire médullaire accrue / réticulocytose sous-estime le dosage.
* Toute situation modifiant la durée de vie des hématies peut impacter le résultat (sous-estimation : anomalie membranaire érythrocytaire, hémoglobinopathie, splénomégalie ; surestimation : splénectomie).
* Une transfusion érythrocytaire dans les 2 mois précédents fausse le dosage.
* Le processus de glycation peut être plus ou moins facilité chez certains patients (« glycateurs forts/faibles ») et peut être à l'origine d'une discordance entre glycémies et HbA1c.

Un dosage des fructosamines est conseillé dans toutes ces situations.

(1) hémolyse impactant le résultat

Le Centre Hospitalier de Luxembourg - Laboratoire de Biologie Clinique est accrédité par OLAS sous le numéro d'accréditation 1/042 pour ISO 15189:2022.

Les analyses précédées de ° du présent compte-rendu font partie de la portée de l'accréditaton.

Compte-rendu validé par : [redacted]

Commentaire Dossier:

GED_C-CHL / GED_C-CHL